

COMPORTAMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE

1. EL DEBER DE AYUDAR A LOS DEMÁS

Los usuarios de las vías que se vean **implicados** en un accidente de tráfico, o que, no estando implicados lo **presencien o tengan conocimiento de él**, están obligados a adoptar las medidas necesarias para:

- Auxiliar o solicitar auxilio para atender a las víctimas, si las hubiese.
- Prestar su colaboración para evitar peligros, restablecer en lo posible la seguridad de la circulación, esclarecer los hechos y colaborar con la Autoridad o sus agentes.

Si en el accidente hubiera resultado **muerta o gravemente herida** alguna persona, o se hubiera **avisado a la Autoridad** o sus agentes, se **evitará la modificación** del estado de las **cosas** y de las **huellas u otras pruebas** que puedan ser útiles para determinar la responsabilidad, **salvo** que de no hacerlo se perjudique la **seguridad** de los **heridos o de la circulación**.

Los usuarios **no implicados, no están obligados** a cumplir estas medidas cuando:

- Se haya personado ya en el lugar del hecho la Autoridad o sus agentes.
- Claramente no sea necesaria su colaboración.

En estos casos conviene continuar y alejarse del lugar, evitando que la curiosidad pueda dificultar la circulación y las medidas de auxilio. Si existen agentes se deben seguir sus indicaciones.

1.1. LA IMPORTANCIA DE LA AYUDA

La importancia del auxilio sobrepasa la obligación comentada. Se trata de una actitud de solidaridad con quien se encuentra en una situación en la que podría estar cualquiera.

Además, la actitud de quien auxilia a un accidentado es vital para la supervivencia y secuelas de éste. Con unos mínimos conocimientos sobre "lo que hay y lo que no hay que hacer" se pueden evitar nuevas lesiones o que se agraven las que ya tiene.

En los 60 minutos posteriores a un accidente se producen el 75% de las muertes, por ese motivo es tan importante que actuemos. La llamada **hora de oro o dorada** puede ser un tiempo determinante para sobrevivir o morir en el caso de sufrir lesiones graves.

1.2. EL CASTIGO PARA LAS PERSONAS QUE NO PRESTEN AYUDA

El socorro y la petición de auxilio para las personas necesitadas es una obligación, y su incumplimiento se castiga en el Código Penal como delito de omisión del deber de socorro. En este delito puede incurrir:

- El que no auxilie a una persona desamparada y en grave peligro, cuando pudiera hacerlo sin riesgo propio ni de terceros.
- El que no pida auxilio con urgencia, si él mismo no puede prestarlo.
- El que haya ocasionado un accidente y no preste auxilio a las víctimas.

ABANDONO DEL LUGAR DEL ACCIDENTE

El conductor de un vehículo que abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente por una acción imprudente en el que fallecieron personas, podrá ser castigado como autor de un **delito de abandono del lugar del accidente** con pena de **prisión de 6 meses a 4 años** y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años.

2. COMPORTAMIENTO EN ACCIDENTE (PAS)

Cualquier persona que se disponga a auxiliar a otra en un accidente debe:

- 1º Hacerse una idea de las circunstancias y consecuencias del accidente (composición de lugar), para establecer un orden de preferencias que garantice la seguridad y el auxilio correcto.
- 2º Después, como norma general debe Proteger, Avisar y Socorrer (PAS). Con el esquema de actuación "PAS" es fácil recordar los pasos que se deben seguir. Es fundamental no precipitarse y mantener la calma, porque el nerviosismo sólo puede contribuir a incrementar la confusión e impedir que se actúe correctamente.

PROTEGER



AVISAR



SOCORRER



2.1. PROTEGER

Cada año mueren muchas personas por parar a ayudar a los accidentados sin tener en cuenta unas mínimas precauciones. Por ello, el que se acerque a socorrer a otra persona debe autoprotgerse, proteger el lugar del accidente y proteger a las víctimas.

2.1.1. ¿CÓMO PUEDO PROTEGERME?

- Debe **detener** el vehículo **en lugar seguro** (intente sacarlo de la calzada y déjelo cumpliendo las normas de estacionamiento).
- Antes de acercarse al lugar del accidente, debe **comprobar que no existe peligro** para su propia vida, de lo contrario, lo mejor será no actuar.
- Debe **evitar invadir la calzada**. Si fuera necesario, hágalo con la máxima seguridad (utilice el **chaleco** y no se confíe).

2.1.2. ¿CÓMO PUEDO PROTEGER EL LUGAR DEL ACCIDENTE?

En el lugar de un accidente, el paso de vehículos es uno de los principales peligros, por lo que es necesario **señalizar** correctamente el obstáculo creado.

Las medidas para proteger el lugar del accidente son:

- Encender la **señal de emergencia**, tanto de día como de noche.
- Dejar encendidas las luces de **posición** cuando corresponda.
- Colocar el **dispositivo luminoso de preseñalización de peligro de color amarillo auto** (señal V-16), el cual envía las coordenadas con la ubicación del vehículo averiado o accidentado al Sistema de Gestión del Tráfico (DGT 3.0) y este, a su vez, reenvía todos los datos a los **vehículos conectados** y al Sistema de Gestión de Incidencias de Tráfico (LINCE), que traslada la información a los **paneles de mensaje variable próximos**.

En caso de no disponer de este dispositivo luminoso **se podrán seguir colocando los triángulos de preseñalización de peligro hasta el 1 de enero de 2026** para indicar la inmovilización del vehículo.



- **Iluminar el lugar** del accidente si fuese necesario con las luces del vehículo (colóquelo perpendicularmente a la calzada y fuera de ella).
- Inmovilizar el vehículo accidentado y **cortar el encendido**.
- **Identificar** si existen **otros peligros** (riesgo de incendio, manchas de gasolina, mercancías peligrosas, etc.).
- No fumar, encender cerillas o hacer fuego, ni permitir que lo hagan otros.
- En caso de incendio sobre el vehículo, utilizar un extintor sobre la base del fuego, y en su defecto, mantas, tierra o arena, pero nunca agua.

Tomando estas precauciones, no sólo se pueden evitar nuevos accidentes sino que se podrá dar una información más completa a los servicios de emergencia.

2.1.3. PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS

- A los heridos **no se les debe mover** salvo que sea imprescindible, ya que pueden agravarse sus lesiones (grave peligro para su médula espinal).
- **El cuello de un herido debe estar protegido** de los posibles movimientos bruscos, **especialmente si el herido está inconsciente**.
- **No se les debe quitar el casco** para evitar lesiones en la columna vertebral, salvo en los casos en los que esté claramente indicado y se conozca la técnica adecuada (mínimo con dos personas). Por ejemplo, si no puede acceder al herido para realizarle la reanimación cardio-pulmonar.



2.2. AVISAR O ALERTAR

La llamada al Servicio de Emergencias, es **una de las actuaciones más importantes** que pueden realizar los auxiliares, ya que en muchos casos la supervivencia del herido depende de la rapidez y la forma en la que se realice esta llamada.

Por ello, se debe **pedir auxilio con urgencia**, a través del **teléfono de emergencia 112**, utilizando el medio más rápido, como el teléfono móvil, los postes S.O.S o solicitando la ayuda de otros usuarios. La llamada es gratuita y se puede realizar desde un teléfono sin PIN ni cobertura. El centro que recibe la llamada coordina todos los efectivos necesarios (sanitarios, bomberos, policía, etc.) en función de las características del suceso.

Lo más adecuado es buscar a alguien que se responsabilice de llamar a los servicios de emergencia, mientras que la persona que tenga más conocimientos de primeros auxilios valora el estado de los heridos e informa al que está llamando.

eCall. Sistema de aviso de emergencia en caso de accidente

Este dispositivo se pone en marcha en **cuanto saltan los airbags del vehículo**, estableciéndose una **comunicación de voz con el centro de emergencias 112** para procurar una movilización efectiva de los servicios de emergencia. La **llamada es gratuita** y tiene cobertura en toda Europa. El sistema envía la información con el lugar exacto del accidente, tipo de vehículo, matrícula, marca, modelo y tipo de combustible. También **se puede activar de forma manual** pulsando el **botón SOS** que llevan los vehículos equipados con este sistema. Actualmente, **todos los turismos y furgonetas nuevos** deberán tenerlo instalado.





¿Qué información debe dar cuando llama al 112?

- Localización del **lugar del accidente** (vía, número, punto kilométrico, localidad, etc.).
- **Número y estado de los heridos, vehículos** implicados y toda la información que se pueda dar sobre ellos.
- **Características del accidente** (personas atrapadas, peligro de caída, etc.).
- Su **identidad**: nombre, teléfono, DNI, para que puedan verificar los datos y pedir más información si fuera necesario (no cuelgue hasta que le den la conformidad).

Además, deberá **avisar a la Autoridad o a sus agentes** y permanecer o volver al lugar del accidente hasta su llegada, a menos que éstos le autoricen a abandonar el lugar, debiera prestar auxilio a los heridos o ser él mismo atendido:

- Si aparentemente hubiera resultado herida o muerta alguna persona.
- Cuando sea necesario para restablecer la seguridad de la circulación.
- Cuando alguna de las personas implicadas en el accidente lo solicite.

No será necesario avisarles, ni permanecer en el lugar del hecho, si sólo se han producido heridas claramente leves, la seguridad de la circulación está restablecida y ninguna de las personas implicadas en el accidente lo solicita.

2.3. SOCORRER

El tercer paso, socorrer, es sin duda esencial. Puede parecer un error atender a los heridos en "último lugar", pero hay que pensar que si se actúa directamente, la asistencia se retrasará y se estará expuesto a peligros innecesarios.

La persona que auxilia tiene la misión de **mantener en las mejores condiciones posibles al herido** hasta que llegue la ayuda sanitaria. Como norma general, el **comportamiento** adecuado será:

- Actuar con rapidez pero sin precipitación.
- Establecer un ambiente de seguridad, **tranquilizar** a las víctimas y **buscar la colaboración** de otras personas, procurando que actúen sólo las necesarias para no estorbarse en la atención a los accidentados.
- Prestar a los heridos el auxilio que resulte más adecuado según las circunstancias. El auxilio debe ser extremadamente cuidadoso con el fin de no agravar su estado. **Si tiene dudas, debe abstenerse de actuar sobre los heridos y dedicarse a proteger, pedir auxilio y prestar apoyo emocional.**
- Se debe atender en **primer lugar** a las víctimas **inconscientes, con dificultades respiratorias graves o con hemorragias masivas.**
- Aflojar las prendas que puedan oprimir el cuello y las vías respiratorias del herido (si es necesario cortarlas o rasgarlas para no moverle).
- **Tapar** a los heridos **ligeramente** incluso en verano.
- **No dar medicamentos**, alcohol, pomadas, cremas, etc.
- **No dar de beber** a los heridos como norma general, y menos bebidas alcohólicas.
- Evitar que los heridos anden o hacerlos andar.



3. TÉCNICAS DE PRIMEROS AUXILIOS (SOCORRER)

Antes de socorrer a un herido **debe** valorar su estado. En el caso de que exista más de uno, debe valorar el estado de **todos antes de comenzar a socorrer a ninguno**.

3.1. EVALUACIÓN PRIMARIA (VALORACIÓN INICIAL)

Lo primero que se debe valorar de un herido son sus funciones vitales: **consciencia, respiración y circulación**, ya que si alguna de ellas falla su vida corre peligro. Esta valoración ha de ser ordenada y breve, menos de 15 segundos.

3.1.1. VALORACIÓN DEL NIVEL DE CONSCIENCIA

Al aproximarse a un herido, lo primero que se debe hacer es ver si responde a estímulos. Para ello, se recomienda realizar preguntas sencillas en un tono alto, o crear un estímulo doloroso (pellizco en el dorso de la mano o similar):

- Si el accidentado responde (abre los ojos, se queja o se mueve), está consciente. En este caso se debe continuar con la valoración de otros heridos si los hubiera, ya que una persona consciente tiene un buen funcionamiento de su aparato circulatorio y respiratorio. No obstante, puede tener lesiones que le hagan perder el conocimiento en cualquier momento, o lesiones de columna vertebral, que harán necesario guardar las mismas precauciones en cuanto a la retirada del casco y la inmovilización del cuello.
- Si el accidentado no responde, estará inconsciente. En este caso se debe **continuar con la valoración** inicial de este herido, **comprobando que** no tiene obstáculos para el paso del aire y que **respira con normalidad**.



Para no olvidar el orden de los pasos a seguir para continuar con la **valoración inicial**, se utiliza una regla compuesta por las 3 primeras letras del abecedario: **ABC**

A	Vía Aérea.
B	Ventilación o Boca.
C	Circulación o Corazón y Hemorragias graves.

Si identifica algún problema, debe intentar solucionarlo antes de continuar con el ABC.

3.1.2. EL ABC (SOLO PARA HERIDOS INCONSCIENTES)

1º (A) Abrir la vía Aérea con la maniobra frente-mentón

Cuando un herido está inconsciente, debe asegurarse que su vía aérea no está obstruida y permite el paso de aire desde la boca y nariz a los pulmones. De lo contrario, podría sufrir lesiones irreversibles en su cerebro derivadas por la falta de oxígeno.

En un **herido inconsciente**, la causa más frecuente de **obstrucción** de la **vía aérea** es la caída de la **lengua** hacia atrás. Esto se debe a que la inconsciencia produce una relajación muscular, que puede hacer que la lengua caiga hacia atrás y obstruya la vía aérea.

Para evitar que el herido se asfixie, es **necesario realizar** la maniobra **frente-mentón** para elevar la lengua y permitir el paso del aire.



La maniobra frente mentón se realiza colocando el dedo índice y medio bajo la **barbilla, elevándola ligeramente**, a la vez que la otra mano se coloca en la frente empujándola hacia atrás **sin realizar extensiones bruscas y/o excesivas del cuello**.

Los dedos índice y medio de la mano que está sobre la frente, deben estar libres para tapar la nariz en caso de necesitarlo para hacer el boca a boca.



Aprovechando la posición, si hubiera algún cuerpo extraño en la boca, lo extraeremos con el dedo índice doblado en forma de gancho y barriendo su interior.

2º (B) Comprobar si el accidentado respira

El auxiliador debe mantener la vía aérea abierta con la maniobra frente mentón, y durante un tiempo **no superior a 10 segundos debe:**

- **VER:** cómo se eleva y desciende el pecho con cada respiración.
- **SENTIR:** el aire espirado en su mejilla.
- **OIR:** la entrada y salida de aire de su boca y nariz.



La propia situación del accidente puede modificar la frecuencia de respiración. Si la variación es muy notable préstele atención.

Para reconocer algún problema respiratorio en un accidentado, hay que saber que en una persona sana la respiración debe tener un ritmo regular, sin períodos de interrupción, y con una frecuencia aproximada de...

- **15 a 20** respiraciones por minuto en los **adultos**.
- **30 a 40** respiraciones por minuto en los **niños pequeños**.

Algunos de los problemas respiratorios que pueden presentar son:

- Respiraciones **ruidosas** (como ronquidos) o **muy dificultosa** (síntoma de **vías aéreas parcialmente obstruidas**).
- Respiraciones **superficiales e irregulares**, con períodos de falta de movimientos respiratorios, (probablemente haya **daño cerebral grave**).

Si no vemos, sentimos o escuchamos la respiración, consideramos que el herido está en parada respiratoria y por tanto es importante notificarlo a los servicios sanitarios.

3º (C) Comprobar la Circulación y las hemorragias que comprometan su vida

La **existencia de circulación** sanguínea se **comprueba observando la respiración**, de forma que si la víctima **no respira** se considerará que está en **parada cardíaca**, debiendo realizarle el masaje cardíaco directamente. Por ello, **no es necesario** comprobar la frecuencia de circulación sanguínea a los heridos **conscientes** que **respiren con normalidad** (se realizará en la evaluación secundaria).

La valoración de las hemorragias, se expone en el punto 3.2.4.

3.2. SITUACIONES QUE NOS PODEMOS ENCONTRAR

3.2.1. ¿SE DEBE SACAR A LOS HERIDOS DEL VEHÍCULO?

Como norma general, a los heridos **no se les debe mover** salvo que sea imprescindible. Siempre es preferible esperar la ayuda especializada, ya que ellos podrán sacarlos del vehículo sin dificultad cuando corten la chapa, retiren las puertas, etc. Además, **tanto la evaluación primaria de la víctima como la mayoría de las actuaciones importantes, a menudo pueden realizarse con el herido en el vehículo.**

No obstante, en casos excepcionales en los que la vida de los heridos esté en peligro, se considera indispensable sacarlos del vehículo. Alguno de estos casos son:

- Cuando exista un alto **riesgo de incendio** o de sufrir un nuevo accidente.
- Cuando sea necesario realizar la **reanimación cardio-pulmonar**.
- Cuando sea necesario colocarlo en **posición lateral de seguridad**.

En estos casos se deberá tratar al herido con sumo cuidado para no provocarle más lesiones; los pasos a seguir son:

- Observar que el cuerpo esté libre (que los pies no están enganchados en los pedales, quitarle el cinturón, etc.). Si está atrapado busque ayuda especializada.
- **Inmovilizar al herido**, especialmente cuando se sospeche que tiene lesión vertebral o medular (el herido dice que no puede mover o sentir alguna parte del cuerpo o cuando haya traumatismo por encima de los hombros y consciencia alterada).
- Colocarse detrás de la víctima, para poder sujetarla correctamente.
- Una vez sujeto, y siempre **manteniendo el ojo cabeza-cuello-tronco alineado** (como un bloque rígido), se le sacará **evitando** que su cuello se mueva.



3.2.2. EL HERIDO INCONSCIENTE QUE RESPIRA (FRENTE-MENTÓN O PLS)

Para **evitar** la **asfixia** de un herido inconsciente debe realizar la **maniobra frente-mentón**, o colocarlo en la **posición lateral de seguridad**.

La **Posición Lateral de Seguridad (PLS)** consiste en colocar al **herido de lado con la boca más baja**, ya que así la lengua no caerá hacia atrás, sino a un lado de la boca y se favorece la salida de vómitos y sangre. Se colocará en esta posición a las **personas** que están **inconscientes** que respiran, cuando:

- Comienzan a **vomit**ar o a **sangrar por la boca**, ya que pueden atragantarse.
- Sangran **por el oído** (sobre el oído que sangra).
- Está **solo** y **tenga** que **abandonarlo** temporalmente para pedir auxilio.



¿Cómo se realiza la PLS?

En heridos por accidente lo aconsejable es realizar esta maniobra entre dos personas, de forma que uno se encargue de mantener inmóvil el eje cabeza-cuello-tronco. En este caso, los auxiliares deben sincronizarse para realizar el giro al mismo tiempo.

Los pasos a seguir son los siguientes

1 Un auxiliar se sitúa detrás de la cabeza del herido, el otro al lado del pecho de la víctima y coloca el brazo más cercano hacia arriba, y la mano del brazo más alejado sobre el hombro del brazo elevado.

2 Flexionar la pierna más alejada y sujetarlo por la rodilla y por el hombro más alejado. Volcarlo sincronizándose con el compañero que controla la cabeza, para que cuerpo y cabeza giren al mismo ritmo.

3 Asegurarse de que la pierna queda flexionada y la cabeza apoyada sobre su mano o antebrazo, para así mantener alineado el eje cabeza-cuello-tronco. Comprobar que la boca y nariz quedan libres.



Cuando sea posible, se debe permanecer a su lado y comprobar la respiración cada 2-3 minutos.

3.2.3. EL HERIDO INCONSCIENTE QUE NO RESPIRA (FRENTE-MENTÓN Y RCP)

Si comprueba que un herido **no respira**, se le debe **realizar inmediatamente** la técnica de **Resucitación Cardiopulmonar (RCP)**, ya que está en parada cardiorrespiratoria.

El objetivo de la RCP es aportar flujo sanguíneo y oxígeno al corazón y al cerebro, mediante maniobras como la respiración boca a boca y el masaje cardíaco. Estas maniobras aplicadas en los primeros minutos pueden evitar la muerte y minimizar las secuelas del herido. Los pasos a seguir son:

1º- Realizar las compresiones torácicas. Para ello se debe:

• Colocar al herido sobre un **plano duro y boca arriba**.

• **Arrodillarse** a su lado a la altura del pecho.

• Colocar el **talón de la mano en el centro del pecho** y el talón de su otra mano sobre la primera.

• **Entrelazar los dedos** y asegurarse de que no aplica la presión sobre las costillas, abdomen o el final del esternón.

• Colocar los **brazos rectos** (perpendicular al pecho) y **dejar caer el peso** del cuerpo para presionar el pecho 4-5 cm (sin doblar los brazos).

• Dejar de presionar sin perder contacto con el herido y **repetir** la compresión hasta alcanzar **un total de 30 compresiones**.

• El tiempo empleado en la compresión y descompresión debe ser igual.



2º- Después de las 30 compresiones debe realizar 2 insuflaciones boca a boca.

Para ello se debe:

- **Mantener abierta la vía aérea** con la maniobra frente-mentón.
- **Pinzar** la parte blanda de la **nariz** con los dedos índice y pulgar de la mano que tiene colocada en la frente.
- **Inspirar** aire normalmente y **colocar los labios** alrededor de la boca abierta de la víctima asegurando que sellan correctamente.
- **Expirar** el aire en la boca del herido mientras **observa que el pecho se eleva** con una duración aproximada de **un segundo**; **en caso contrario**, debe comprobar que la maniobra frente-mentón se ha realizado correctamente y que la boca no está obstruida.
- Mantener la maniobra frente-mentón, **retirar su boca** y observar como desciende el pecho al salir el aire.
- **Si la primera insuflación ha sido eficaz, se debe realizar una 2ª insuflación** de la misma forma.
- Si no entra aire, repetir las 30 compresiones e intentar de nuevo las ventilaciones.

**3º- A continuación colocar de nuevo las manos en el centro del pecho y continuar realizando compresiones y ventilaciones a un ritmo de 30/2.**

Si por algún motivo no se pudieran realizar insuflaciones, realizar únicamente compresiones torácicas a una frecuencia continua de 100 por minuto (algo menos de 2 por segundo).

Si hay más de un reanimador, deben **alternarse** cada 1-2 minutos para prevenir la fatiga, procurando tardar lo mínimo posible en el cambio.

La secuencia de RCP que se ha explicado para adultos, **se puede utilizar también en niños**. No obstante, el niño se puede beneficiar de las siguientes modificaciones:

- Se empieza haciendo **5 ventilaciones de rescate**. Las ventilaciones se pueden realizar **boca a boca o boca a boca nariz**, en niños pequeños.
- Al realizar las compresiones se tiene que **comprimir el tórax aproximadamente un tercio de su profundidad**. En este caso se debe utilizar:
 - 2 dedos para los niños menores de un año.
 - Una o dos manos para niños mayores de un año.

¿Cuándo se debe dejar de realizar la RCP?

- Cuando llegue ayuda cualificada que lo releve.
- Cuando la víctima comience a respirar normalmente (volver a valorar su estado).

3.2.4. EL HERIDO SANGRA ABUNDANTEMENTE (CONTENER HEMORRAGIAS)

Un adulto sano tiene unos 7 litros de sangre. Con una pérdida de más de 2 litros ya suele estar inconsciente y con riego cerebral insuficiente. Por ello, las hemorragias que primero se deben controlar son las que **sangren muy abundantemente** (sobre todo si lo hace a borbotones), ya que el resto de hemorragias generalmente no suponen riesgo para la vida.

Clasificación de las hemorragias

Arteriales	Venosas	Capilares
		
La sangre sale a borbotones con un color rojo vivo.	La sangre sale de forma continua con un color rojo oscuro.	La sangre sale por pequeños puntos sangrantes.
Externas	Internas	Internas exteriorizadas
		
La sangre sale al exterior.	La sangre se queda en el interior del organismo.	La sangre derramada en el interior sale al exterior por el oído, nariz, boca, etc.

¿Cómo se contiene una hemorragia abundante?

1º Realizar presión directamente sobre el punto sangrante. Se debe poner alguna gasa, venda o trapo limpio, sin levantarlo ni cambiarlo aunque se manche para evitar que vuelva a sangrar. Recomendable usar guantes.



2º Si con la presión sobre la herida no es suficiente, hay que elevar el miembro afectado manteniendo la presión. Así se dificulta la salida de la sangre por la herida.

3º Si la presión junto con la elevación del miembro no es suficiente, será necesario además, presionar la arteria correspondiente en su tramo anterior a la herida.



4º Como último recurso se puede realizar un torniquete.

Esta actuación y la presión de la arteria contra el hueso, puede poner en peligro la vida del herido, por lo que **solo** se realizará en caso de **amputación** o cuando **no se consiga cohibir la hemorragia** con las medidas comentadas.

El torniquete consiste en aplicar un pañuelo, venda, tela o goma sobre el miembro afectado por encima de la hemorragia, de forma que al apretarlo comprima la arteria sobre el hueso e impida el paso de sangre.

Entre la piel y el pañuelo o elemento utilizado, hay que colocar un elemento rígido (palo, destornillador, etc.) con el fin de que al girarlo, se vaya apretando el pañuelo para ejercer una presión gradual que consiga cortar la hemorragia o que disminuya de forma importante.

Para hacer un torniquete nunca se debe utilizar una superficie dura (alambre, cuerda, etc.) o muy estrecha (mínimo 5 cm), ya que al apretarlo puede producir lesiones importantes o cortes en la extremidad.

¿Qué se debe hacer una vez aplicado el torniquete?

- Hay que mantenerlo **sin quitarlo ni aflojarlo**, ya que pueden aparecer complicaciones muy graves que pueden causar la muerte.
- No se debe tapar con la ropa.
- **Se debe colocar un cartel, que indique la hora** en la que se realizó, en un lugar visible de la ropa.



La aplicación de un torniquete es una de las causas que justifican el traslado del herido al hospital antes de que llegue la ayuda sanitaria.

En caso de amputación debe

- Cubrir la zona con gasas, almohadillar con algodón y comprimir con un vendaje.
- Si existiera una hemorragia muy abundante, aplicar un torniquete.
- Lavar la parte desprendida con agua, cubrirla con gasas estériles, introducirla en una bolsa o recipiente hermético y sumergir la bolsa o el recipiente en agua con cubitos de hielo (evitar contacto directo con el hielo).
- Procurar el traslado inmediato a un centro e informar del tipo de lesión.

3.2.5. LAS HEMORRAGIAS INTERNAS

Este tipo de hemorragias son especialmente peligrosas, ya que al derramarse la sangre internamente, no se aprecia su pérdida y puede dañar algún órgano del cuerpo.

Existe la posibilidad de que la sangre derramada internamente salga al exterior por los orificios naturales del cuerpo (hemorragia exteriorizada).



Si la sangre sale **por el oído**, puede ser debido a una fractura de la base del cráneo. En este caso se debe colocar al **herido en la posición de defensa** o **PLS sobre el oído que sangra** y cubrir el oído con una gasa estéril (nunca taponar).

Si la sangre sale **por la nariz**, puede ser debido a una fractura del cráneo. En este caso si el herido está inconsciente se le colocará en posición de seguridad.

Si sangra **por la boca**, puede ser debido a:

- Una lesión de pulmón (sangra con golpes de tos). Colocarlo en posición semisentado.
- Una lesión de estómago (vómitos de sangre). Colocarlo en posición de defensa o PLS.

Estas hemorragias presentan una situación de extrema gravedad. Nunca deben taponarse.



3.2.6. EL HERIDO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE SHOCK

Cuando un herido pierde mucha sangre, tanto si sale al exterior como si no, puede dar lugar a un shock (colapso) de intensidad gradual y progresiva.

Los síntomas de un herido que se encuentra en **estado de shock** son: un **color de piel pálido**, sudor frío, inquietud, confusión, **pulso rápido y débil** y respiración rápida y superficial. Cuando un herido presente estos síntomas se debe:

- Solicitar ayuda lo antes posible.
- Aflojarle las ropas que puedan oprimir alguna parte del cuerpo (cuello, cinturón, etc.).
- Colocarlo en **"posición antishock"**: la cabeza más baja que el resto del cuerpo y con las piernas elevadas.
- **Tapar ligeramente** al herido **para conservar su temperatura** (sin hacerle sudar). Si lo tapa en exceso la sangre se desplazará hacia la piel en vez de hacia los órganos vitales empeorando su situación.
- No dar líquidos a estos heridos por el riesgo de que haya vómitos o pérdida de consciencia, pudiendo originar complicaciones respiratorias muy graves.
- Observar cuidadosamente su estado y si comienza a manifestar signos de inconsciencia, náuseas o vómitos, se colocará a la víctima en "posición de defensa".



3.3. EVALUACIÓN SECUNDARIA (SIGNOS NO VITALES)

Cuando se esté seguro que el herido está consciente y respira con normalidad, se le puede tomar el pulso y comprobar si tiene hemorragias leves, fracturas u otras lesiones.

El **primer** pulso a explorar en un accidentado es el **carotideo**, ya que es el más seguro para comprobar la **existencia** de bombeo del corazón. Este pulso se localiza presionando suavemente con el dedo índice y medio sobre un lado del **cuello**, cerca de la línea media (debajo del ángulo de la mandíbula). A continuación, se realiza la misma operación sobre el otro lado, pero **sin presionar las dos arterias a la vez**, ya que puede impedir que la sangre llegue al cerebro.

Para saber la frecuencia de bombeo (pulso) también se puede explorar la arteria **radial (muñeca)**.

No se puede utilizar el dedo **pulgar**, pues se puede confundir con el propio pulso.



Para saber la frecuencia cardiaca se necesita palpar la arteria durante 1 ó 2 minutos.

Ritmo aproximado de latidos del corazón

- **60 a 80 veces por minuto** en los **adultos** sanos.
- Alrededor de **100 veces** por minuto en los **niños**.

No obstante, los accidentados tendrán frecuencias más elevadas por el estrés y el nerviosismo.

Una frecuencia cardíaca elevada puede significar riesgo vital del herido; las personas en estado de shock pueden tener taquicardias, es decir, frecuencias más elevadas.

3.3.1. FRACTURAS

Son lesiones muy habituales en accidentes de tráfico que a menudo, ocasionan importantes complicaciones que pueden poner en peligro la vida del herido. Los síntomas de una persona que ha sufrido una fractura ósea son:

- **Dolor intenso en la zona** (a veces tarda un poco en aparecer).
- Hipersensibilidad en la zona fracturada.
- **No pueden mover la zona** correspondiente al hueso dañado.
- Edema y hematoma (acumulación de líquido, sangre o ambos bajo la piel).
- Acortamiento y deformidad: sobre todo se aprecia en las extremidades.
- Crepitación, ruido característico que produce el roce de los fragmentos.





¿Qué se debe hacer en caso de fractura?

- **Tapar la herida y cohibir la hemorragia** en el caso de fracturas abiertas y complicadas.
- **Nunca reducir una fractura** (se pueden dañar vasos sanguíneos, músculos y nervios).
- **Inmovilizar la zona** de la fractura:
 - Sujutando la zona. Es importante sujetar **los dos extremos de la fractura**, por debajo y por encima, para que no se mueva.
 - Con un cabestrillo. Para las extremidades superiores la utilización de un vendaje que se sujete al cuerpo puede ser una solución fácil y útil.
 - Entablillando la extremidad fracturada (no hacerlo si no se conoce el método).



Lo más habitual es que un herido en accidente de tráfico sea un politraumatizado, es decir, que sufre varias fracturas graves así como las complicaciones que las acompañan.

Ante este tipo de lesionados, el auxiliador se limitará a controlar las funciones vitales y evitar lesiones sobreañadidas por inadecuada manipulación o transporte.

3.3.2. ¿QUÉ HAY QUE HACER SI EXISTE ALGUNA HERIDA GRAVE?

- No tocar la herida salvo que exista una hemorragia y sea necesario reducirla.
- **No retirar los objetos** clavados (puede aumentar la lesión y la hemorragia).
- Tapar la herida, con el objeto incrustado, con un apósito fijado por un vendaje e inmovilizar en bloque al paciente junto con el objeto.
- En caso de salida de vísceras, acostar al lesionado y cubrir los órganos con paños humedecidos evitando tocarlos. Procurar no mover al herido.

3.3.3. QUEMADURAS POR CALOR

Las quemaduras más habituales en los accidentes son producidas por el incendio del vehículo y la abrasión del cuerpo al rozar con el asfalto.

En caso de tener que extinguir el fuego que quede en las ropas del herido, se le debe hacer **rodar o taparlo con una manta** o un material similar para cortar (ahogar) el fuego, intentando envolverlo para tapar la mayor superficie posible de su cuerpo.

Nunca se utilizará agua para eliminar el fuego de las ropas del herido. Si se utiliza un extintor, no se debe emplear directamente sobre su cuerpo.

El comportamiento correcto ante un herido con quemaduras es...

- **No tocar** la zona quemada, **ni retirar la ropa** que quede adherida a la piel.
- **No pinchar ni cortar las ampollas** que puedan aparecer por la quemadura.
- **No aplicar nunca pomada o ungüento** alguno en la zona quemada.
- **Aplicar agua fría**. Si es posible introducir la zona quemada en agua.

- **Cubrir** la herida con apósitos limpios y **humedecidos** en agua. Si la zona quemada es extensa, se pueden utilizar telas que estén a mano (por ejemplo sábanas o toallas limpias). De esta forma disminuye en parte la pérdida de líquido por las mismas.
- Fijar los apósitos con un vendaje, una vez colocados y siempre que sea posible.
- En caso de tener que vendar **dos superficies quemadas no vendarías nunca juntas**, siempre hacerlo por separado.
- Si es posible, **mantener elevada la zona quemada** para disminuir el edema, el dolor y la hinchazón.
- Vigilar al herido, sobre todo la posible aparición de shock (colapso) y, en caso de quemaduras en la región de la cara, la aparición de dificultades respiratorias.



4. MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA AUTORIDAD O SUS AGENTES

Además de avisar a la Autoridad o sus agentes, se deberá:

- Facilitar la documentación personal, del vehículo y todos los datos que pida el agente.
- Proporcionar información sobre cómo se produjo el accidente.
- Someterse a las pruebas de alcoholemia, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas. Como norma general, los usuarios que no estén implicados en el accidente no están obligados a realizar dichas pruebas.

5. PROPORCIONAR LOS DATOS

Las **personas obligadas a prestar su ayuda**, deben **comunicar su identidad** y la del **vehículo** (matrícula, seguro, etc.) a las **personas implicadas que lo pidan**.

Si solo se causan pequeños daños materiales, lo acertado es llegar a un acuerdo entre implicados y comunicarlo a las compañías aseguradoras en el plazo más breve posible. Cuando solo se hubieran ocasionado daños materiales y alguna parte afectada no estuviera presente, el causante debe tomar medidas adecuadas para proporcionarle cuanto antes, su nombre y dirección, bien directamente o en su defecto, por medio de los agentes de la Autoridad.

6. MOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE LOS HERIDOS

En el caso de necesitar mover a un herido, hay que hacerlo **como si fuera un bloque rígido**. Para ello, como mínimo son necesarias 3 personas, los cuales se colocarán de rodillas a los lados del herido e intercalarán sus manos para poder elevarlo **manteniendo inmovilizado el eje cabeza-cuello-tronco**.

La **Unidad de Accidentes de Tráfico** hospitalaria es, un servicio de **atención a las víctimas con lesiones, físicas o emocionales, derivadas de un siniestro vial**, así como de gestión de los trámites administrativos con la compañía de seguros. A ellas pueden acudir todas las personas involucradas, tanto los conductores como los acompañantes, además de los peatones y los motoristas. Es gratuito, ya que son **las aseguradoras las que asumen estos gastos**, siempre que el lesionado **no sea el culpable del accidente**, no se encuentre bajo los efectos del **alcohol** o las **drogas** o el vehículo **carezca de seguro**.



El traslado de heridos por accidente debe hacerse en vehículos destinados para tal fin y por personal sanitario. Sin embargo, se dan casos en que es necesario trasladar al herido urgentemente, pudiendo utilizar un vehículo particular.



Excepciones

1. Cuando no haya sido posible solicitar ayuda sanitaria por ningún medio.
2. En el caso que empeore gravemente su estado y la ayuda sanitaria no llegue.
3. Si han pasado más de 30 minutos desde que se solicitó la ayuda y el herido tiene:
 - Una hemorragia externa imposible de contener o signos de shock en aumento.
 - Un torniquete.

No hay que olvidar que tanto **para mover al herido como para su traslado**, antes es preciso asegurarse de que se va a realizar con **unos REQUISITOS MÍNIMOS**:

1. Manteniendo alineado el **eje cabeza-cuello-tronco**.
2. En la **posición más adecuada** para el estado del herido.
3. Con un vehículo que permita cumplir estas condiciones (camión, furgón, etc.).

El trayecto a recorrer hasta el centro hospitalario debe hacerse...

- Circulando a una velocidad moderada y con la máxima suavidad posible.
- Con alguien que acompañe al herido para intentar tranquilizarle y ayudarlo.

7. EL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS

Aunque no es obligatorio, **si es recomendable** llevar un botiquín en buenas condiciones con guantes, compresas estériles, vendas, gasas, apósitos estériles, un pañuelo grande, esparadrapo, tijeras, pinzas, imperdibles y alguna solución desinfectante.



